Agent Infirmerie

État des lieux — ce qu'il fait, ses forces, ses faiblesses · 24/10/2026

À lire d'abord : ce n'est pas un agent autonome

« Agent Infirmerie » désigne deux choses distinctes. Une **spécification** (LAB 04) qui fixe son rôle, sa mission et sa règle d'or. Et une **application** qui la met en œuvre : 9 modèles de données, 12 écrans, 96 tests automatisés.

Rien ne s'exécute en arrière-plan : ni planificateur, ni tâche de fond, ni démon. **L'agent ne fait rien tant qu'un humain n'ouvre pas un écran.** C'est le point le plus important de cet état, et celui qui explique la plupart des faiblesses qui suivent.

1. Ce qu'il fait, étape par étape

La spécification décrit un workflow en cinq étapes. Voici où chacune en est réellement, vérifié dans le code et non dans les intentions.

Étape de la spec	État réel
1. Recevoir et enregistrer	**Fait.** Dossier patient, consultation, bilan, mesures, allergies, suivis.
2. Analyser et extraire	**Partiel.** Extrait les valeurs d'un bilan *saisi à la main*. Ne lit aucun document : pas d'import de PDF de laboratoire.
3. Prioriser et signaler	**Fait.** Point quotidien en deux sections : Immédiat (allergies sévères) et Avant la visite (valeurs hors norme, échéances).
4. Consolider le briefing	**Fait.** Briefing imprimable, brouillons de relance justifiés par un fait du dossier.
5. Valider et archiver	**Fait.** Validation humaine obligatoire ; journal d'accès horodaté.

Le workflow s'arrête à la porte de l'étape 2. L'application ne lit pas de document : on saisit, elle organise et signale. C'est une différence de nature avec ce que le mot « agent » suggère.

2. Forces

Ce qui tient, et pourquoi ce n'est pas une promesse mais une propriété du code.

La règle d'or est dans le code, pas dans une consigne.

« Ne jamais deviner une donnée médicale » n'est pas un rappel : c'est une branche du programme. Une valeur sans borne complète, ou non chiffrée (« négatif », « traces »), sort en « à qualifier » — jamais en « normal ». Une borne haute seule suffit à conclure, une borne basse seule non. Couvert par des tests.

Il n'envoie rien.

Les relances sont des brouillons. L'écran le dit en haut, et un test échoue si un appel réseau apparaît dans le module. La validation humaine est une étape du workflow, pas une option.

Les accès sont fermés côté serveur.

Le secrétariat qui saisit l'URL d'une fiche clinique reçoit un 403. Le lien n'est pas seulement masqué : la vue refuse. Testé, y compris pour garantir qu'aucune page clinique ne s'ouvre par inadvertance.

Deux bases séparées.

Les patients fictifs vivent dans une base, les vrais dossiers dans une autre. Une erreur de manipulation sur la démonstration ne peut pas atteindre les données réelles, et les sauvegardes sont indépendantes.

Les fourchettes viennent du laboratoire, pas de normes génériques.

13 paramètres chargés, versionnés. Un contrôle vérifie en plus que l'unité reste cohérente avec les bornes : c'est ce qui a détecté une glycémie étiquetée « 5,4 g/L — Normal » alors que la valeur était en mmol/L, donc dangereuse à lire.

Les relances sont justifiées par un fait vérifiable.

« Dernier bilan du 26/08/2025 — 401 jours. » Un compte, pas une appréciation. Le soignant peut contester le fait affiché.

Le journal d'accès ne contient aucune donnée clinique.

Qui, quand, quel rôle, quel dossier. Jamais une valeur de mesure, jamais un résultat. Un journal qui recopierait les données créerait un second dossier, non maîtrisé.

3. Faiblesses

Par ordre d'importance réelle pour un usage de soin. Les trois premières empêchent une mise en service sur de vrais dossiers.

#	Faiblesse	Conséquence concrète
1	**Aucune autonomie.** Rien ne s'exécute sans qu'un humain ouvre l'écran.	Le « zéro oubli » de la spec repose sur la vigilance de quelqu'un. Si personne n'ouvre l'application, aucun oubli n'est évité.
2	**La prophylaxie n'existe pas.** Aucun modèle, aucun écran.	Le bloc vaccinal de la spec n'est pas commencé. Seule une analyse écrite existe, en attente des calendriers de l'établissement.
3	**La couverture biologique est étroite.** 13 paramètres, tous d'hématologie.	Toute la biochimie — glycémie, créatinine, ferritine, lipides — ressort « à qualifier ». Honnête, mais la majorité d'un bilan courant n'est pas interprétée.
4	**Les seuils de relance sont arbitraires.** 365 jours pour un bilan ancien, 730 pour une absence.	Ce sont des choix de développement, pas des règles validées par un soignant. Ils déclencheront des relances inutiles ou en manqueront.
5	**Les sauvegardes ne se déclenchent pas seules.** Les scripts existent, rien ne les planifie.	Et la restauration n'a jamais été testée. Une sauvegarde jamais restaurée n'est pas une sauvegarde, seulement une copie.
6	**Aucune notification.** Si un bilan devient anormal, personne n'est prévenu.	Cohérent avec « aucun envoi automatique », mais tout le poids repose sur la consultation de l'écran.
7	**Un seul poste, une seule base SQLite.**	L'accès distant par VPN n'est pas configuré. Aucun test à deux utilisateurs simultanés.
8	**Mots de passe de démonstration identiques** pour tous les comptes.	Signalé depuis le début, jamais changé. À faire avant toute ouverture à un tiers.
9	**L'anonymisation repose sur la discipline, pas sur du code.**	La règle interdit que noms et données nominatives entrent en mémoire longue. Rien ne l'empêche techniquement.

4. Verdict

Utilisable aujourd'hui

En pilote supervisé, sur données fictives, par une seule personne : enregistrer un patient, saisir un bilan, voir ce qui presse, rédiger une relance, l'imprimer. Les trois forces structurantes — règle d'or, aucun envoi, accès fermés — tiennent dans cet usage.

Pas utilisable en production réelle, en l'état

Trois blocages, dans cet ordre :
1. Les mots de passe, identiques et publics dans le dépôt.
2. Les fourchettes de biochimie, sans lesquelles la majorité des résultats reste « à qualifier ».
3. Une sauvegarde dont la restauration n'a jamais été testée.

5. Ce qui reste à faire, par nature

Chantier	Nature	Ce qu'il faut pour avancer
Module prophylaxie	Développement	Calendriers vaccinaux et protocoles de l'établissement
Planification des tâches	Développement	Décision sur ce qui peut être automatisé sans validation
Sources documentaires	Développement	Inventaire des protocoles et fiches types autorisés
Fourchettes de biochimie	Donnée	Seconde feuille du laboratoire
Durée de conservation	Décision	Règle de l'établissement, pas un choix technique
Mots de passe, sauvegarde testée	Exploitation	Rien à concevoir : à exécuter

Le code est prêt à accueillir ces éléments. Aucun des trois chantiers LAB 04 ne bute sur une difficulté technique : tous attendent une donnée ou une décision qui ne peut venir que de l'établissement. Aucun agent ne les inventerait — et c'est précisément la règle d'or qui l'interdit.